

乙胺碘呋酮的药物相互作用

北京第二传染病医院 李锡岩

提要 了解抗心律失常药之间及与其它药物的相互作用尤为重要。本文对乙胺碘呋酮与其它抗心律失常药以及与一些药物可发生的相互作用作了一个概述。

关键词 乙胺碘呋酮, 地高辛, 奎尼丁, 普鲁卡因酰胺, 安搏律定, 慢心律, 苯妥英钠, 双异丙吡胺, 缓脉灵, 安他唑啉, 心律平, 钙拮抗剂, β 受体阻滞剂, 华法令, 麻醉剂。

乙胺碘呋酮 (Amiodarone, 简称胺碘酮) 为目前应用广泛、高效、长效、毒性较低的一种广谱抗心律失常药。有些顽固而严重的心律失常, 单用某种抗心律失常药物常不能获得满意疗效或无效。因而, 在临床治疗中常联合用药, 以达到剂量小, 疗效更佳的目的。这就必然存在复杂的药物相互影响, 使其效应增强或减弱, 毒性加大或减小, 若不采取相应措施, 对病人将有一定危险性。因此, 了解抗心律失常药之间及与其它药物的相互作用尤为重要。

现将胺碘酮与其他抗心律失常药以及与其它药物可发生的相互作用概述如下。

地高辛 应用胺碘酮治疗的患者, 当加用地高辛治疗时可显著提高血清地高辛浓度 (SDC)。机理是由于该药抑制肾小管对地高辛的分泌。据报道, 口服地高辛维持量 (0.25mg/d), 加服胺碘酮 (200mg , 3次/d), 结果 SDC 平均增加 69% (从 $1.17\mu\text{g/L}$ 增至 $1.98\mu\text{g/L}$), 可致地高辛中毒。近年的文献报告, 长期投用地高辛的患者, 并用胺碘酮 $600\sim 1600\text{mg/d}$ 、经 1~2 周后 SDC 增高 104%, 且与地高辛的投用量无关, 另据报道, 对口服胺碘酮 400mg/d 的患者静注 1mg 地高辛, 地高辛的肾清除率、非肾清除率、全身清除率分别减少 2%、32%、26%; 地高辛的排泄半衰期从 34 ± 13 小时延长至 40 ± 6 小时。故为了维持稳定的

SDC 在应用胺碘酮时, 地高辛剂量宜减到 $1/2\sim 4/1$ 。

奎尼丁 联合应用, 可致 Q-T 间期延长和尖端扭转型室速, 药动学研究发现 11 例加用胺碘酮后, 奎尼丁血清浓度增加了 31.8% ($P<0.001$)。这可由于胺碘酮降低奎尼丁在组织中的结合率, 使其释放到血液, 降低 Vd 之结果。因而, 两药并用时, 奎尼丁剂量应减少 37%。

普鲁卡因酰胺、安搏律定 12 例应用胺碘酮后普鲁卡因胺血清浓度从 $6.8\pm 1.8\mu\text{g/ml}$ 增至 $10.6\pm 9.8\mu\text{g/ml}$, 平均增加 57%。两者合用时普鲁卡因酰胺的剂量应减少 20%。胺碘酮还使安搏律定的血浓度自 2.3mg/L 升至 3.5mg/L , 可发生 Q-T 延长和扭转型室速等。

慢心律 两者起协同作用。有人报道, 二药联用慢心律的剂量可减半, 室速的转变率提高到 100%。国内联用治疗顽固性心律失常, 疗效确比单用效果好。但联用后对胺碘酮所致的传导抑制, 可使其加重, 并可引起 Q-T 延长和扭转型室速, 故二药联用尚有争论。

苯妥英钠 苯妥英钠的作用类似利多卡因, 在高浓度时仍可抑制传导, 与胺碘酮联用治疗洋地黄中毒所致的顽固性心律失常较理想, 但可引起 Q-T 延长和扭转型室速, 并可直接抑制窦房结导致心脏停搏。合并用药应

避免或慎重。

双异丙吡胺、缓脉灵、安他唑啉、心律平 因不属同一类药物且抗心律失常的机制亦异，故临床上可以联用，但亦能引起Q-T延长和扭转型室速，不可忽视。

钙拮抗剂 胺碘酮有阻滞交感神经活动的作用，减低窦房结自律性和延长房室结不应期。钙拮抗剂亦有抑制窦房结自律性、房室传导性作用。当二者并用时，更减慢窦性心率，增加房室传导阻滞，甚至引起严重后果。故对窦性心动过缓、病窦综合征或部分房室阻滞的病人，胺碘酮与某些钙拮抗剂，如异搏定和硫氮草酮可进一步减慢窦率或加重房室阻滞，联合用药时应谨慎。

β 受体阻滞剂 胺碘酮有非竞争性阻断肾上腺素能 α 和 β 受体作用，可降低窦房结自律性，延长房室结有效不应期。在窦性心动过缓，病窦综合症或不完全性房室传导阻滞时，胺碘酮与 β 受体阻滞剂可加重心动过缓和房室传导阻滞，联合用药可能产生一个附

加作用，因此必须慎重使用。

华法令 胺碘酮增强华法令的抗凝作用。这一作用在联用胺碘酮3~4天即可出现，停用胺碘酮，这一作用仍可持续数周或数月。胺碘酮对凝血酶原活性的影响与剂量无关。胺碘酮可干扰华法令代谢。两药合用时，华法令剂量应减少1/3~1/2，且对凝血酶原时间进行监视，同样，它也影响肝素的活性。

麻醉剂 手术中曾观察到胺碘酮与麻醉剂合用时出现低血压及阿托品无效的心动过缓。

总之，胺碘酮药物相互作用，除上述之外，还得继续探索去发现。胺碘酮及其代谢物浓集于肝脏，故有可能妨碍肝的药物代谢。另外与地高辛相互作用于肾脏，提示也可能干扰某些药物的肾脏清除。为了防止心血管药物并用后的中毒影响，临床用药时必须警惕这些较多的相互作用。

(参考文献从略)

酮 洛 芬

[Medical Letter 1986, 20 June (英文)]

酮洛芬是一种非类固醇抗炎药(NSAID)，某些国家已使用10余年了；最近美国用其治疗关节炎。从化学上说，它是与布洛芬、甲氧萘丙酸、苯氧苯丙酸、噻丙酚有关的苯丙酸衍生物。

药代动力学 酮洛芬很快从胃肠道吸收，在肝内结合，主要作为葡萄糖醛酸从尿中排泄。磷酸铝或氢氧化铝和氢氧化镁抗酸剂不影响药物吸收。文献报道的半衰期，年青人3小时，老年人5小时，肾功能减退的病人可延长。

临床试验 在120例的3个月双盲试验中发现，酮洛芬150~400mg/天治疗风湿性关节炎和布洛芬(1200~2400mg/天)的疗效

相似。在几种治疗风湿性关节炎的短期试验中，也发现它有消炎痛、保泰松、甲氧萘丙酸同样的功效。在几个骨关节炎患者的短期治疗中，它比对照组有效，和保泰松功效一样。

副作用 洛芬的副作用常和其它非甾体抗炎药物相似。服药的病人可发生周围性水肿和间质性肾炎，据报道，有包括黄疸敏严重肝脏反应。局部使用酮洛芬可引起光的感性反应。

与其它药物相互作用 酮洛芬和氨甲喋呤同时使用治疗的4例病人均发生了严重的氨甲喋呤中毒，其中3例死亡。与羧苯磺胺同

(下转第13页)